

Información Paciente

Nombre : Julia Aída Carmen Oviedo Vidal
Edad : 68a 11m 11d
Dirección : San Francisco De Asis # 8189

Rut : 7.428.229-6
Fecha Nacto: 31/03/1953
Comuna : La Florida

N° Archivo : 0936900
Sexo : Femenino
Teléfono : 9 88288590

N° Epicrisis
299030

Información Hospitalización

Unidad de Ingreso : Upc - Uci Adulto
Unidad de Egreso : Upc - Uci Adulto

Fecha Ingreso : 06/03/2022 19:15
Fecha Egreso : 11/03/2022 11:03

Días Estadía: 5

Motivo o Diagnóstico de Ingreso

traslado HLF

Comorbilidades

Procedimientos

Intervenciones Quirúrgicas

Epidemiología

Resumen Clínico

EPICRISIS

11-3-22

Julia Oviedo Vidal
68 años
RUT: 7428229-6
FIH: 06/03/2022
FIUCI: 07/03/2022

AM: Distrofia Miotónica de Steinert compromiso cardica Fibrilo luter , HTA, Trastorno del Ánimo, Artrosis, DM2NIR, Hipotiroidismo

AQ: HT, Cataratas

Medicamentos: Fenitoina, Amitriptilina, Fluoxetina, Amiodarona, Espironolactona, Metformina.

Alergias: No conocidas

Paciente ingresa derivada desde Hospital La Florida, por hemorragia cerebral extensa, ganglionar, asociada a hemoventrículo e hidrocefalia, ingresa a pabellón de urgencia para DVE. Tiempo de stroke hemorrágico y compromiso de conciencia : < 12 horas antes de llegar a HSR.

TAC de cerebro, del 06-03-2022

Hematoma intraparenquimatoso centrado en la región de los núcleos de la base de izquierdos que mide aproximadamente 36 x 25 x 34 mm en los ejes ortogonales y cefalocaudal respectivamente, marginado por edema vasogénico.

Determinada significativo efecto de masa caracterizado por desviación de la línea media de 3-4 mm a nivel de agujeros de Monro y herniación transtentorial descendente incipiente, y obliteración difusa del espacio subaracnoideo de los surcos fronto-parieto-temporal de predominio izquierdo.

Se asocia a extenso vaciamiento hacia ambos ventrículos laterales, tercer ventrículo y cuarto ventrículo, con dilatación difusa del sistema ventricular reflejando hidrocefalia obstructiva secundaria.

No se observan colecciones yuxtadurales.

Hematoma intraparenquimatoso ganglionar izquierdo que determina severa efecto de masa y se asocia a vaciamiento al sistema ventricular con hidrocefalia obstructiva secundaria. Por sus características considerar etiología hipertensiva

Fecha Epicrisis : 11/03/2022 11:53

Pasa a Pabellón de Urgencia (6/3/22) instalándose DVE sin incidentes ,
 , Se toma muestra de LCR que resulta no inflamatorio
 , Sale a recuperación donde inicia requerimientos de vasoactivos y se mantiene sedada
 El día 7-3-22 se traslada a UCI donde se mantiene sedada con vasoactivos , destaca en exámenes PCR elevada se toman cultivos y se inicia unasyn por sospecha de aspiración CCAET con secreciones purulentas
 Se toma TAC de cerebro de control que evidencia aumento de hidrocefalia , , valorado por Nx se define bajar DVE a -5 cm y mantener manejo
 La paciente evoluciona grave con requerimientos de vasoactivos , agregándose el día 10.3.22 PCR en actividad eléctrica sin pulso , saliendo a los 2 minutos con masaje . posterior a esto mayor deterioro falleciendo el día 11-3-22 a las 11.15 hrs en presencia de su familia

Diagnóstico

- 1- hemorragia ganglionar extensa izquierdo con vaciamiento a ventrículos
- 2- Hidrocefalia obstructiva 2ra
- 3- neumonía aspirativa
- 4- Distrofia muscular

Dra Lisbona

Diagnóstico de Egreso

Accidente vascular hemorrágico (HIC) - hidrocefalia

Condición de Egreso

Fallecido

Egreso con Catéter Doble J:NO

Plan Post Alta

Indicaciones

Tipo de Reposo :

Régimen Alimentario :

Medicamentos :

Controles

INTERNO

Becado/Residente


María L. Lisbona Torres
Médico Tratante (Staff)